Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent9vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5062075-59.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: ZELIA CARDOSO ANICET

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

ZELIA CARDOSO ANICET ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA**, ambos já qualificados. Referiu que é portadora de *fibrose pulmonar idiopática grave* (CID 10:J84.1) e, em razão de sua condição, carece fazer uso da medicação *nintedanib 150mg* para o tratamento necessário. Referiu que, ao solicitar autorização do tratamento perante a operadora de plano de saúde, ora requerida, teve a cobertura negada, sob o argumento de que o tratamento proposto não está previsto nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Discorreu acerca de seu estado de estado de saúde, bem como dos fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão. Referiu que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, e não taxativo. Postulou, em sede de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada à operadora requerida que custeasse imediatamente o tratamento. Juntou documentos, anexou procuração e postulou a gratuidade judiciária.

Recebida a inicial e deferida a tutela de urgência, com o escopo de determinar que o réu fornecesse pelo período necessário ao tratamento da parte autora, o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) 150mg 12h/12h, por tempo indeterminado, ou o depósito do valor correspondente ao tratamento (evento 3, DESPADEC1).

Citada e intimada, a requerida informou não deter interesse em conciliação (evento 21, PET1).

Ofertada contestação (evento 33, CONT1). Em sua peça defensiva, a demandada asseverou que o rol da ANS é reconhecidamente taxativo, conforme 2ª Seção do STJ, o que embasa a negativa de cobertura derivada da operadora do plano de saúde. Defendeu, em suma, que não almeja questionar a funcionalidade do medicamento para a autora; entretanto, não havendo cobertura para fornecimento de medicação domiciliar e não oncológica, não se pode impelir à ré responsabilidades além daquelas contratadas, reguladas pela lei e de acordo com as normas da ANS, sob pena de causar grave desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde. Por fim, asseverou que eventual deferimento do pedido ampliaria sobremaneira a cobertura contratada, implicando na modificação também do cálculo atuarial para a manutenção do contrato.

Sobreveio réplica (evento 37, RÉPLICA1).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de provas (evento 40, DESPADEC1).

A autora requereu o imediato julgamento do feito (evento 44, PET1), assim como a requerida (evento 47, PET1).

Em vista do documento juntado com a manifestação do evento 47 da requerida, a autora foi instada a se manifestar (evento 50, DESPADEC1), o que foi feito ao evento 53, PET1..

É o relatório. Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, em que a parte autora pretende a condenação da ré ao fornecimento do medicamento *Nintedanibe (Ofev)*, que lhe fora prescrito por seu médico assistente, para a patologia que lhe acomete.

Com efeito, a parte autora é portadora da patologia classificada no CID-10 como *fibrose pulmonar idiopática grave* (CID 10:J84.1), e em razão da doença, lhe fora prescrito o tratamento com a utilização da medicação *Nintedanibe (Ofev)*, na dose de 150mg, duas vezes ao dia, conforme evento 1, LAUDO4.

Desse modo, a autora, que possui plano de saúde junto à ré, solicitou o custeio do tratamento, o qual foi negado, sob a justificativa de que o fármaco não estaria previsto nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos dos arts. 17, §1º, VI, e 18, IX e X, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, uma vez que seria medicamento para uso domiciliar/ambulatorial (evento 1, DECL8).

Sendo assim, verifico que a controvérsia existente no presente feito versa sobre a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento pleiteado pela autora.

Inicialmente, destaco que incidem à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista, de forma a serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, com base no art. 47 do referido diploma legal.

No mesmo sentido, destaco que o E. STJ aprovou a Súmula nº 469, assim redigida:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Desta feita, concluo que, frente às peculiaridades do caso posto em análise, a negativa ao fornecimento do medicamento, necessário e indicado para o tratamento da doença da autora, importa, na verdade, na negativa do previamente avençado, pois a doença que acomete a demandante tem CID especificado, constando, porquanto, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionado à Saúde da OMS, cujas coberturas são garantidas pela Lei nº 9.656/98, regras as quais a ré afirma se submeter.

No que se refere aos debates envolvendo o rol da ANS, destaco que não assiste razão à parte ré ao arguir seu caráter taxativo, de forma a excluir o tratamento pleiteado pela autora, pois, como se observa, o §12, do art. 10, da referida Lei nº 9.656/98, com alteração decorrente da Lei nº 14.454/2022, é claro ao dispor que o rol de procedimentos da ANS consiste em referência básica para os planos privados de saúde, de modo que persiste seu caráter meramente exemplificativo.

Inclusive, quanto ao caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, destaco o posicionamento do E. STJ no mesmo sentido:

> *CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.*
> *4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.954.574/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)*

Outrossim, no caso em apreço, o medicamento foi aprovado pela ANVISA, com indicação para o tratamento de *Fibrose Pulmonar*, conforme se extrai da bula eletrônica (Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=103670173) e do parecer emitido pela ANVISA e pela Superintendência de Medicamentos e Produtos Biológicos (SUMED) para registro do fármaco no país (Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=OFEV), de maneira que comprovada sua eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, com fulcro no art. 10, §13, inciso I, da Lei nº 9.656/98, sendo necessária a sua cobertura pelo plano de saúde.

Ademais, aponta a ré que o fármaco postulado pela autora não estaria nas hipóteses excepcionais de cobertura pelo plano, uma vez que não se trata de medicação antineoplásica ou caso de internação domiciliar, conforme art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. Entretanto, em consulta realizada no sítio da ANVISA, além de constatar que o medicamento *Nintedanibe (Ofev)* está regularmente registrado, esse se encontra classificado como antineoplastico[1], ratificando-se, portando, a obrigatoriedade de cobertura

Nesse ponto, apesar do medicamento se destinar principalmente ao tratamento de patologia distinta (câncer de pulmão), destaco que a sua prescrição à comorbidade da autora está amparada pelo laudo do médico que lhe assiste (evento 1, LAUDO4), o que deve prevalecer.

Assim, aos planos de saúde cabem apenas estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito para o tratamento da doença que acomete a autora ou simplesmente substituí-lo, pois isso compete ao profissional da medicina que assiste o paciente, como mencionado.

Da mesma forma, tenho que a imprescindibilidade da utilização do medicamento pela autora está devidamente comprovada nos autos, sendo que o não uso do fármaco acarreta, até mesmo, risco de óbito à requerente. Veja-se, nesse sentido, o teor do laudo médico acostado ao evento 1, LAUDO4:

> A Sra Zelia Cardoso Anicet tem diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática grave, CID 10: J84.1. Esta é uma doença pulmonar grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse. Necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com nintedanib 150mg 12/12h, sendo este medicamento disponível no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado. Paciente tem diagnóstico em 2021, com perda de função pulmonar progressiva. Paciente se mantém com dispnéia mesmo em repouso. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. Tomografia de tórax mais recente apresenta sinais de fibrose pulmonar idiopática padrão UIP. Apresenta hipoxemia em repouso (SaO2 85) em uso de O2 domiciliar continuo .Espirometria com CVF 0,959 (39%) e sem condiçoes de medir DLCO. Provas de doença autoimune negativas e ausência de exposição ambietal ou ocupacional . O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática, com o objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS. Caso o paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte.

Logo, entendo que se mostra descabida a negativa de fornecimento do fármaco, porquanto, como já referido, o que deve prevalecer é a existência de previsão para cobertura à enfermidade e não a forma como ela deve ser ministrada, cabendo somente ao médico que assiste o segurado, e não à seguradora, a eleição do tratamento, de modo que afasto o argumento deduzido pela ré no evento 33, NOTATEC4, acerca da disponibilidade de demais opções tecnológicas disponíveis, porque já exauridas.

Ainda na mesma linha acima, certo é que o médico que assiste, que acompanha e que tem contato direto com o paciente é, sem dúvida, aquele que pode prescrever o tratamento de saúde mais adequado ao seu estado clínico, motivo pelo qual o tratamento em tela deve ser considerado como legítimo e passível de cobertura pela demandada.

Dessa forma, não há como afastar a obrigação da ré em fornecer o tratamento e a medicação pleiteada pela parte autora através da presente ação. Em caso semelhante aos autos, cito entendimento do E. TJ/RS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIBROSE PULMONAR. OFEV (NINTEDANIBE). ANTINEOPLÁSICO ORAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 3. No ponto, cumpre destacar que, conforme jurisprudência desta c. Câmara Cível, o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo, o que foi ratificado pela inclusão do §12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98. 4. Não obstante o caráter exemplificativo do Rol da ANS, o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais, das medicações em regime de home care e dos incluídos no rol da ANS. 4. No presente caso, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porquanto concernente a medicamento recomendado pela médica assistente, conhecedora das peculiaridades do quadro clínico do autor, e previsto no Rol da ANS, ainda que para patologia distinta (câncer de pulmão), reputando-se absolutamente indevida eventual interpretação restritiva das diretrizes de utilização. 5. Outrossim, entre as exigências mínimas previstas na Lei está a cobertura de tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral, segmento no qual se inclui o medicamento Nintedanibe, conforme consta de seu registro na ANVISA. E, estando o medicamento incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadra-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde. 6. De qualquer sorte, nos termos do § 13, inciso I, do art. 10 da Lei n° 9.656/98, é possível a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 6. In casu, o medicamento postulado é tratamento eficaz para a patologia que acomete a parte autora (fibrose pulmonar), à luz da medicina baseada em evidências. Ainda, destaca-se que o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com indicação para o tratamento de Fibrose Pulmonar, conforme consta na bula. Além disso, há diversas notas notas técnicas extraídas do sistema e-NatJus favoráveis ao tratamento. 5. De consequência, com fulcro no §11 do artigo 85 do CPC, restam majorados os honorários devidos pela parte ré aos procuradores da parte autora. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 51456679820228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-10-2023)*

Ainda, sobre a alegação de o fornecimento do medicamento causar desequilíbrio atuarial, também não pode prosperar a negativa, haja vista que cabe à operadora de plano de saúde se cercar de cuidados quantos a esses riscos, planejando suas contas e definindo os limites das coberturas que oferecerá nos contratos. Não cabe é transferir ao segurado, usuários de seus serviços, eventual ônus demasiado que se apresente pela acentuação da demanda.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos formulados por **ZELIA CARDOSO ANICET** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** e confirmo a tutela antecipada concedida para, com base no art. 487, inciso I, do CPC, resolver o mérito da ação e determinar que a ré forneça a medicação Nintedanibe (Ofev) 150 mg, nos exatos termos da indicação médica, na quantidade indicada pelo médico, pelo período que se fizer necessário, de acordo com a avaliação exclusiva do médico assistente da autora.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do procurador da parte adversa, que estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, considerando a natureza da ação e o trabalho desenvolvido, atualizado pelo IPCA a partir desta data, bem como acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **TAMARA BENETTI VIZZOTTO, Juíza de Direito**, em 7/2/2024, às 16:2:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10053408129v59** e o código CRC **c6fa014c**.

---

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351345738202004/ ↩